

高齢者のための嚥下内視鏡検査評価表 **Hyodo・Komagane score**

患者氏名

M / F 年齢 診断名 検査実施日 / /

① 唾液貯留

- 0 : 【唾液貯留無し】 唾液貯留がない。
- 1 : 【喉頭蓋谷唾液貯留】 喉頭蓋谷のみ唾液貯留あり。
- 2 : 【梨状陥凹唾液貯留 喉頭腔流入無し】 梨状陥凹に唾液貯留があるが喉頭腔への流入はない。
- 3 : 【梨状陥凹唾液貯留 喉頭腔流入有り】 梨状陥凹に唾液貯留があり喉頭腔へ流入する。

①

② 咳嗽反射の惹起性と声門閉鎖（喉頭蓋先端部に触れる）

- 0 : 【即反射】 1 回の刺激で著明に反射が惹起される。
- 1 : 【反射は起こるが弱い】 1 回の刺激で反射は惹起されるが弱い。
- 2 : 【反射が起きないことがある】 2 ～ 3 回の刺激でようやく反射が惹起される。
- 3 : 【反射が起きない】 3 回の刺激でも反射が惹起されない。

+

②

③ 水分ゼリー¹⁾（3 ml）嚥下反射の惹起性

- 0 : 【咽頭時反射】 水分ゼリーの咽頭流入が観察できる。
- 1 : 【喉頭蓋谷時反射】 水分ゼリーが喉頭蓋谷に達するのが観察できる。
- 2 : 【梨状陥凹時反射】 水分ゼリーが梨状陥凹に達するのが観察できる。
- 3 : 【梨状陥凹反射遅延】 水分ゼリーが梨状陥凹に達してもすぐには嚥下反射が起きない。

+

③

④ 水分ゼリー¹⁾（3 ml）嚥下後の咽頭クリアランス

- 0 : 【残留無し】 嚥下後に梨状陥凹および喉頭蓋谷に水分ゼリーの残留なし。
- 1 : 【残留あるが処理可】 水分ゼリー残留が軽度あるが、2 ～ 3 回の空嚥下で wash out される。
- 2 : 【残留あり】 水分ゼリー残留があり、複数回嚥下を行っても wash out されない。
- 3 : 【残留物の流入あり】 水分ゼリー残留が高度で、披裂部を越えて喉頭腔へ流入する。

+

④

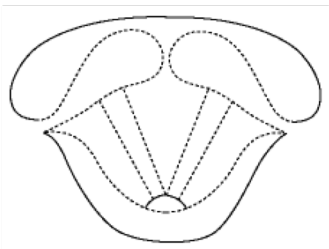
入院中の患者は検査前に栄養科に連絡してエンゲリートを1個出してもらうこと

①+②+③+④

食事の提案、コメントなど

合計

嚥下内視鏡の所見



判定基準（4項目スコア合計）

- ☐ 7 点以下：
経口摂取可（ペースト食）
- ☐ 8 点：
リハビリ等にて経口摂取の可能性検討
- ☐ 9 点以上：
経口摂取困難